核心精讲

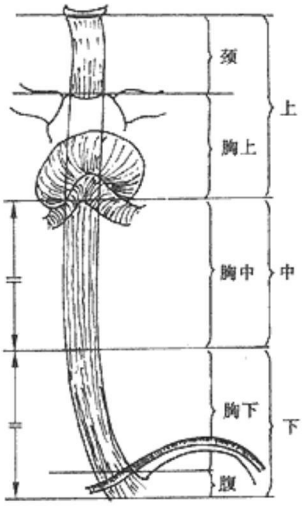
食管疾病

（性感认识：食管癌进行性吞咽困难）

一、食管癌 外科 食管疾病&乳房疾病 00:00:00-00:04:53

（一）病理

1.早期食管癌：不侵犯肌层，无论有无局部淋巴结转移



2.中晚期（阳伞虽窄、胸中有水）

①髓质型：最常见

②蕈伞/隆起型

③溃疡型：梗阻相对较轻

④缩窄/硬化型：环形狭窄致较早梗阻

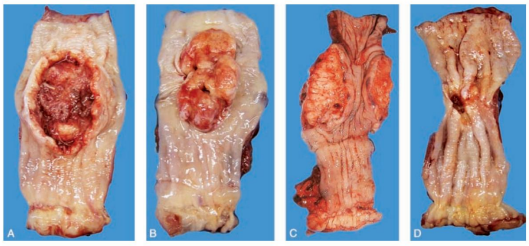


图 11-11　食管癌大体类型

A. 溃疡型；B. 蕈伞型；C. 髓质型；D. 缩窄型。

3.好发于胸中段

4.我国以鳞癌多见；欧美以腺癌多见（与 Barrett 食管有关）

5.淋巴转移最早最常见，晚期易转移至左锁骨上淋巴结的 Virchow

注意：食管癌、胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结，而肺癌易转移至右锁骨上淋巴结

（二）临床表现和检查

1.中晚期表现：进行性吞咽困难

①侵犯一侧喉返神经→声音嘶哑

②侵犯颈交感神经→Horner 综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）winkttsx

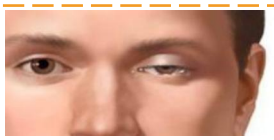
③食管破入气管形成瘘→进食后呛咳

「理顺知识点」

- 任何原因（eg. 肺癌、食管癌、甲状腺癌、甲状腺手术）导致的交感神经损伤都会引起 Horner 综合征





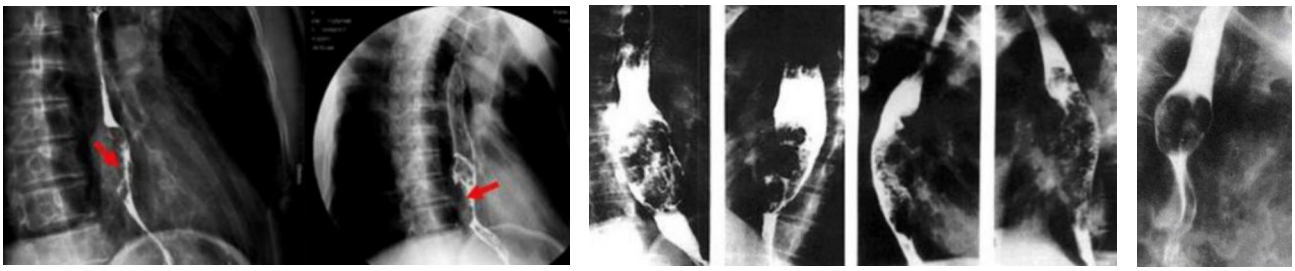


2.检查

①内镜：首选、金标准

②食管拉网脱落细胞学：筛查

「理顺知识点」
- 极早期的食管癌内镜难以取到，此时可选食管拉网脱落细胞学
- 钡餐描述充盈缺损、管壁僵硬→恶性



（三）治疗

1.首选根治术：切肿块及其上下缘≥5-8cm 的组织（五八同城买食材），消化道重建最常用的食管替代物是胃

2.颈段及胸上段（距门齿＜25cm）、或发生远处转移：首选放疗（放了尔我）

「理顺知识点」
- 颈段及胸上段食管癌毗邻大血管神经，若行手术难以保证对肿瘤切除干净→首选放疗

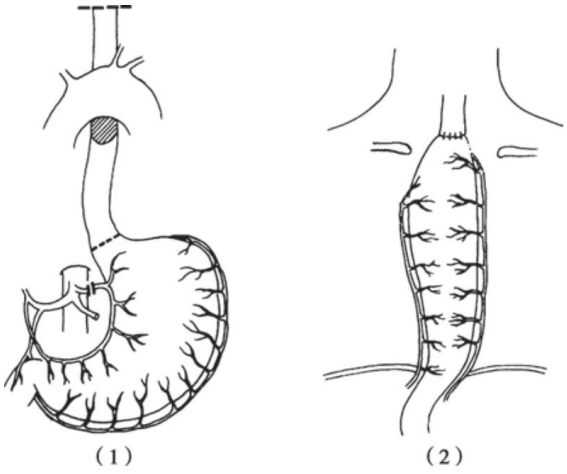


图 30-2　食管癌切除术后胃代食管术
(1)上、中段食管癌的食管切除范围　(2)胃代食管、颈部吻合术

二、贲门失弛缓症

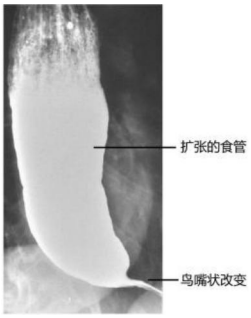
外科 食管疾病&乳房疾病
00:04:53-00:05:37

①与精神因素等相关，多见于青年女性

②食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌 LES 不能松弛→间歇性吞咽困难，钡餐鸟嘴样狭窄

③治疗：食管下段贲门肌层切开 Heller 术。在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病







真题解析 ·食管疾病

外科 食管疾病&乳房疾病
00:05:37-00:06:46

1.2021N60 A 女性，32 岁。间断吞咽困难伴呕吐十年。上消化道造影提示食管明显扩张，蠕动减弱，食管末端呈“鸟嘴”样狭窄，狭窄部黏膜尚光滑。宜采取的手术方式是

A.食管下段、贲门部肌层切开术

B.食管下段+近端胃切除术

C.食管大部分切除，胃代食管术 治疗食管癌

D.腹腔镜胃底折叠术 治疗胃食管反流病

2.2025N61A 食管癌切除术最常用的食管替代物是

A.空肠

B.结肠

C.胃

D. 回肠

答案：1-2 A C